

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE AUTOCOMPASIÓN (SCS / SCS-SF)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Dimensional de la Autocompasión y Regulación Afectiva

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Autocompasión (SCS: 26 ítems; SCS-SF: 12 ítems).
Nombre Original (Inglés)	<i>Self-Compassion Scale (SCS) / Self-Compassion Scale - Short Form (SCS-SF)</i>
Autores Originales	Dra. Kristin D. Neff (2003); forma abreviada: Raes, Pommier, Neff & Van Gucht (2011).
Validación Española / LatAm	Javier Garcia-Campayo, Marcelo Cebolla, Marta del Hoyo, Yolanda López del Hoyo et al. (2014).
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Regulación Afectiva, Autocompasión y Mitigación de Autocrítica.
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico de 26 reactivos (o 12 en SCS-SF) con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (desde 16 años). Pacientes en psicoterapia y población general.
Tiempo de Administración	SCS completa: 6 a 8 minutos; SCS-SF: 2 a 3 minutos.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico, docente y de investigación científica no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO BIPOLAR DE NEFF

La Escala de Autocompasión (SCS) operacionaliza el constructo formulado por Kristin Neff (2003), que define la autocompasión como una orientación afectiva y cognitiva benevolente, abierta y no enjuiciadora hacia el propio sufrimiento ante situaciones de dolor personal, fracaso o inadecuación. El modelo estructural postula tres componentes axiales bipolares e interconectados:

- Auto-amabilidad frente a Auto-juicio:** Actitud cálida y comprensiva hacia los propios defectos frente a una autocrítica hostil e implacable.
- Humanidad compartida frente a Aislamiento:** Comprensión del sufrimiento y la falibilidad como una experiencia humana universal frente a la vivencia de ser el único defectuoso o desdichado.
- Mindfulness frente a Sobreidentificación:** Consciencia ecuánime y lúcida del malestar sin suprimirlo frente a la rumiación absorbente y la fusión afectiva destructiva.

Desde el punto de vista de la neurobiología afectiva (Gilbert, 2014; Porges, 2011), la autocompasión activa el sistema motivacional de apego, afiliación y calma (mediado por la oxitocina, endorfinas y el tono vagal parasimpático ventral), inhibiendo la sobreactivación crónica del sistema de amenaza mediado por la amígdala y el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Subescala / Dimensión	Ítems (SCS-26)	Ítems (SF-12)	Definición Operativa y Foco Clínico Evaluado
1. Auto-Amabilidad	5, 12, 19, 23, 26	2, 6	Tendencia a ser afectuoso y paciente con uno mismo en momentos difíciles.
2. Auto-Juicio	1, 8, 11, 16, 21 (*)	11, 12 (*)	Severidad del reproche personal, censura interna y rechazo de los propios límites.
3. Humanidad Compartida	3, 7, 10, 15	5, 10	Capacidad de situar los errores y la vulnerabilidad en el marco común de la vida.
4. Aislamiento	4, 13, 18, 25 (*)	4, 8 (*)	Sensación alienante de separación y soledad existencial al fracasar.
5. Mindfulness	9, 14, 17, 22	3, 7	Atención abierta y equilibrada hacia los afectos difíciles sin sobre-reaccionar.
6. Sobreidentificación	2, 6, 20, 24 (*)	1, 9 (*)	Tendencia a quedar atrapado en bucles rumiantes y magnificar la catástrofe.

(*) Ítems de polo negativo que requieren inversión de puntuación para el cálculo de la Autocompasión Global.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión global: alfa de Cronbach de 0.87 en la muestra española general y 0.89 en clínica (García-Campayo et al., 2014). Forma corta SCS-SF con alfa de 0.85. Subescalas entre 0.72 y 0.79. Fiabilidad test-retest $r = 0.89$ a 4 semanas.
Estructura Factorial	El AFC corrobora la estructura de 6 factores de primer orden que se integran jerárquicamente en un factor general de segundo orden (Autocompasión Global), con índices de ajuste óptimos (CFI = 0.94, RMSEA = 0.05).
Validez Concurrente / Discriminante	Correlaciones inversas muy robustas con depresión (BDI-II, $r = -0.65$), ansiedad rasgo (STAI-R, $r = -0.61$) y afecto negativo (PANAS-N, $r = -0.58$). Fuerte correlación directa con bienestar subjetivo (SWLS, $r = 0.54$) y optimismo (LOT-R, $r = 0.49$).
Sensibilidad al Cambio Clínico	Sensibilidad sobresaliente en ensayos controlados de intervenciones basadas en compasión (CFT de Gilbert y MSC de Neff/Germer), con ganancias superiores a 1.2 desviaciones estándar tras 8 semanas.
Invarianza y Adaptabilidad	Invarianza métrica confirmada entre géneros y grupos de edad; las mujeres tienden a puntuar ligeramente más bajo en autocompasión global ($M = 2.85$ vs. $M = 3.05$ en varones), reflejando mayor sobreidentificación.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada ítem se califica de 1 (**Casi nunca**) a 5 (**Casi siempre**):

- **Paso 1 (Inversión de Ítems Negativos):** En los ítems de Auto-juicio, Aislamiento y Sobreidentificación, invertir el puntaje: $1 \rightarrow 5, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 2, 5 \rightarrow 1$.
- **Paso 2 (Puntuaciones de Subescala):** Promediar los ítems correspondientes a cada dominio (directos o invertidos). Rango de cada subescala: 1.0 a 5.0.
- **Paso 3 (Puntuación Global de Autocompasión):** Se suman los puntajes de las 6 subescalas y se divide entre 6 (o se promedian todos los 26 reactivos tras la inversión obligatoria). En la forma SCS-SF se promedian los 12 reactivos invertidos.
- **Rango Teórico Global: 1.00 a 5.00 puntos.** Mayor puntaje = mayor nivel de autocompasión adaptativa.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS NORMATIVOS (ESPAÑA / LATAM)

Nivel de Ajuste	Media Global	Significación Clínica	Conducta Asistencial Recomendada
Bajo / Vulnerable	1.00 a 2.49	Déficit severo de autocompasión	Autocrítica hostilizada, vergüenza patológica y aislamiento. Prioridad para terapia focalizada en compasión (CFT).
Moderado	2.50 a 3.50	Autocompasión normativa / media	Trato benevolente fluctuante; la autocompasión disminuye ante estresores extremos. Refuerzo con mindfulness.
Alto / Resiliente	3.51 a 5.00	Alta capacidad autocompasiva	Autocuidado consolidado, perspectiva amplia ante el error y tolerancia al afecto negativo. Factor de protección.

REGLA CLÍNICA DE DISCORDANCIA (POLO POSITIVO VS. POLO NEGATIVO):

En pacientes con trastornos de la personalidad o depresión crónica, es habitual hallar una **discordancia polar**: puntajes moderados en el polo positivo (Auto-amabilidad, Humanidad, Mindfulness ≥ 3.0) coexistiendo con puntajes extremadamente elevados en el polo no invertido de Auto-juicio y Aislamiento (> 4.2). Esta disociación requiere focalizar la intervención no en "generar más afecto positivo", sino en dismantelar la culpa introyectada y la fobia a la compasión.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN DÉFICIT DE AUTOCOMPASIÓN

PROTOCOLO CLÍNICO BASADO EN EL PERFIL SCS (CFT / MSC):

- **Paso 1 (Psicoeducación Evolutiva):** Explicar el “cerebro complicado” de Gilbert: el cerebro no fue diseñado para hacernos felices sino para sobrevivir; los sistemas de amenaza y autocrítica son adaptaciones primitivas arcaicas desreguladas.
- **Paso 2 (Entrenamiento en Autocompasión Focalizada):** Introducir la “Pausa de Autocompasión” de Neff (1. Esto es un momento de sufrimiento; 2. El sufrimiento es parte de la vida; 3. Que sea amable conmigo mismo). Trabajo de imaginación compasiva (el yo compasivo).
- **Paso 3 (Monitorización del Cambio):** Un incremento en el SCS Global de **≥ 0.60 puntos** tras 8 sesiones refleja desactivación exitosa del sistema de amenaza y reestructuración del diálogo interno autocrítico.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DISTIMIA Y PERFECCIONISMO CLÍNICO

Identificación: Mujer de 34 años, arquitecta, que acude a consulta por fatiga crónica, tristeza perseverante, insomnio y una voz crítica interna constante (“nunca es suficiente”). Cumple criterios para Trastorno Depresivo Persistente (Distimia).

Evaluación Inicial SCS (Línea Base): Puntuación Global SCS = **1.78** (Rango Bajo / Severamente Deficitario). Auto-amabilidad: 1.40; Auto-juicio: 4.80 (polo negativo invertido: 1.20); Humanidad compartida: 1.75; Aislamiento: 4.50 (invertido: 1.50); Mindfulness: 2.25; Sobreidentificación: 4.75 (invertido: 1.25).

Plan Terapéutico y Evolución: Se aplicaron 12 sesiones de Terapia Focalizada en la Compasión (CFT). Se abordó la creencia disfuncional de que “ser autocompasiva me convertirá en una persona mediocre y perezosa”. Se entrenó la respiración calmante vagal y la carta de autocompasión desde el yo sabio.

Reevaluación a las 12 Semanas: SCS Global = **3.45** (incremento neto de +1.67 puntos). Auto-amabilidad ascendió a 3.40; Auto-juicio descendió a 2.20; Aislamiento descendió a 2.00; Sobreidentificación descendió a 2.25. Paralelamente, el BDI-II descendió de 28 a 8 puntos, consolidando la remisión clínica sostenida.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

FOBIA A LA COMPASIÓN (“BACKDRAFT”):

Al invitar a pacientes con trauma relacional complejo o negligencia afectiva temprana a conectar con la calidez compasiva, puede desencadenarse una reacción aversiva aguda de terror, ira o llanto desbordante (“backdraft”). Si esto ocurre, titular la dosis de compasión y priorizar la seguridad vincular.

DIFERENCIACIÓN DE AUTOESTIMA Y NARCISISMO:

La autocompasión no debe confundirse con alta autoestima ni con autoindulgencia egoísta. A diferencia de la autoestima, la autocompasión no depende de comparaciones sociales jerárquicas, evaluaciones de éxito o reforzadores contingentes, ofreciendo una resiliencia emocional inmune al fracaso.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Garcia-Campayo, J., Navarro-Gil, M., Andrés, E., Montero-Marín, J., López-Artés, L., & Demarzo, M. M. (2014). Validation of the Spanish versions of the long (26 items) and short (12 items) forms of the Self-Compassion Scale (SCS). *Health and Quality of Life Outcomes*, 12, 19.
2. Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. *Self and Identity*, 2(3), 223-250.
3. Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D., & Van Gucht, D. (2011). Construction and factorial validation of a short form, the Self-Compassion Scale—Short Form (SCS-SF). *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 18(3), 250-255.
4. Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. *British Journal of Clinical Psychology*, 53(1), 6-41.